

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE REGULACIÓN EMOCIONAL (ERQ)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de Estrategias de Reevaluación Cognitiva y Supresión Expresiva

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ).
Nombre Original (Inglés)	<i>Emotion Regulation Questionnaire (ERQ)</i>
Autores Originales	Drs. James J. Gross y Oliver P. John (2003), Stanford University / UC Berkeley.
Adaptación Española	Rodríguez-Carvajal, Moreno-Jiménez y Garrosa (UAM, 2006); validación de Cabello et al. (2012).
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo Procesual de Regulación Emocional (Gross).
Tipo de Instrumento	Autoinforme escalar de 10 reactivos tipo Likert de 7 puntos (1 a 7).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (desde los 13 años). Población clínica ambulatoria y comunitaria.
Tiempo de Administración	2 a 4 minutos en autoadministración; 5 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Dominio público para uso clínico, docente e investigación científica sin royalties comerciales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO PROCESUAL DE GROSS

El ERQ es el instrumento psicométrico de referencia global fundamentado en el **Modelo Procesual de la Regulación Emocional** de James Gross. Este marco postula que las emociones se despliegan a lo largo de una trayectoria temporal (situación, atención, valoración cognitiva y respuesta emocional), permitiendo diferenciar entre dos tipos fundamentales de regulación según el momento de su implementación:

- Reevaluación Cognitiva (Estrategia Antecedente):** Consiste en transformar deliberadamente la interpretación subjetiva de una situación potencialmente estresante o emocional antes de que la respuesta emocional se active en su totalidad. Neurobiológicamente recluta la corteza prefrontal ventrolateral y dorsolateral junto al córtex cingulado anterior, modulando eficazmente la amígdala con mínimo coste cognitivo y preservando el bienestar subjetivo.
- Supresión Expresiva (Estrategia Consecuente o de Respuesta):** Consiste en inhibir voluntariamente la conducta expresiva y somatovegetativa externa de la emoción una vez que ya ha surgido. No reduce la vivencia interna ni el arousal fisiológico; por el contrario, incrementa la activación simpática (ritmo cardíaco, conductancia dérmica), consume ingentes recursos atencionales ejecutivos y bloquea la intimidad relacional.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dimensión Regulatoria	Ítems	Rango Dir.	Operacionalización y Enfoque Afectivo
1. Reevaluación Cognitiva (RC)	1, 3, 5, 7, 8, 10	6 a 42 (1–7)	Modificación del significado subjetivo. Abarca modulación de emociones tanto positivas (ítems 1, 3, 8) como negativas (ítems 5, 7, 10).
2. Supresión Expresiva (SE)	2, 4, 6, 9	4 a 28 (1–7)	Ocultamiento voluntario de la manifestación motora, mímica y verbal. Cubre inhibición de afecto positivo (ítem 4) y afecto negativo (ítems 2, 6, 9).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad en España: alfa de Cronbach de 0.79 a 0.84 para Reevaluación Cognitiva y de 0.75 a 0.79 para Supresión Expresiva (Cabello et al., 2012; Rodríguez-Carvajal et al., 2006).
Estructura Bifactorial	El AFC demuestra el ajuste idóneo de dos factores ortogonales independientes (CFI = 0.96, RMSEA = 0.052), demostrando que ambas estrategias no son opuestas, sino independientes.
Estabilidad Temporal	Fiabilidad test-retest $r = 0.71$ para Reevaluación y $r = 0.73$ para Supresión a los 3 meses.
Validez Concurrente	La Reevaluación correlaciona positivamente con autoestima ($r = 0.42$), bienestar subjetivo y optimismo, e inversamente con depresión (BDI-II, $r = -0.32$). La Supresión correlaciona positivamente con alexitimia (TAS-20, $r = 0.48$), afecto negativo y hostilidad interpersonal.
Sensibilidad al Cambio	Sensible a intervenciones de Reestructuración Cognitiva TCC, Terapia de Aceptación y Regulación Emocional Sistémica, mostrando aumentos en RC y descensos en SE postratamiento.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 10 ítems se responde en una escala de 1 a 7 (1 = «Totalmente en desacuerdo», 4 = «Neutral», 7 = «Totalmente de acuerdo»). El cuestionario arroja dos puntuaciones independientes:

- **Subescala Reevaluación Cognitiva (RC):** Suma de los ítems 1 + 3 + 5 + 7 + 8 + 10 (Rango: 6 a 42; o media aritmética dividiendo entre 6, rango 1 a 7).
- **Subescala Supresión Expresiva (SE):** Suma de los ítems 2 + 4 + 6 + 9 (Rango: 4 a 28; o media aritmética dividiendo entre 4, rango 1 a 7).
- **Nota Crucial:** Nunca debe calcularse una puntuación total agregada sumando los 10 ítems, puesto que Reevaluación y Supresión son dimensiones factorialmente ortogonales.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y BAREMOS DE REFERENCIA

Nivel Estratificado	RC (Suma / M)	SE (Suma / M)	Significación Clínica y Perfil de Afrontamiento
Bajo	≤ 24 (< 4.0)	≤ 11 (< 2.8)	En RC: Deficiencia en reframing cognitivo. En SE: Baja tendencia a reprimir emociones (expresión espontánea sana o descontrol desinhibitorio).
Medio / Típico	25 a 33 (4.1–5.5)	12 a 17 (2.9–4.3)	Perfil equilibrado normal. Uso flexible de la valoración cognitiva con supresión moderada circunscrita a contextos sociales formales.
Alto	≥ 34 (> 5.6)	≥ 18 (> 4.4)	En RC: Excelente capacidad de reevaluación adaptativa. En SE: Supresión crónica y desadaptativa; riesgo elevado de aislamiento y quejas somáticas.

PERFILES REGULATORIOS EN ATENCIÓN CLÍNICA:

El perfil de máximo riesgo psicopatológico es la combinación de **Baja Reevaluación Cognitiva (RC < 24)** con **Alta Supresión Expresiva (SE ≥ 18)**. Este patrón es habitual en trastornos del estado de ánimo, fobia social y somatización, indicando un paciente que sufre intensamente sin modificar cognitivamente el estresor mientras hace un esfuerzo agotador por aparentar normalidad exterior.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA MODULAR

DIAGRAMA DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PERFIL ERQ:

- **Perfil 1: Baja RC + Alta SE (Perfil Disfuncional Típico):** Prioridad 1: Psicoeducación sobre el coste psicofisiológico de la supresión afectiva. Prioridad 2: Entrenamiento en asertividad y expresión emocional segura. Prioridad 3: Terapia Cognitiva basada en Reestructuración o Defusión ACT para potenciar la flexibilidad de pensamiento.
- **Perfil 2: Alta RC + Alta SE (Controlador Eficaz pero Rígido):** Explorar áreas de desgaste interpersonal o perfeccionismo relacional. Fomentar la apertura emocional en vínculos íntimos de confianza.
- **Perfil 3: Baja RC + Baja SE (Desregulación Emocional Abierta):** Frecuente en TLP y trastornos del control de impulsos. Priorizar protocolos de tolerancia al malestar y habilidades de regulación de la Terapia Dialéctica Conductual (DBT).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN ANSIEDAD SOCIAL

Paciente: Varón de 29 años, docente de secundaria, consulta por intensos síntomas de ansiedad y tensión física previa a impartir clases y reuniones de claustro. Teme ruborizarse o tartamudear y que los demás perciban su inseguridad.

Resultados del ERQ en Línea Base:

- **Reevaluación Cognitiva (RC): 18 puntos** (Media = 3.0, Nivel Bajo; déficit marcado en reframing ante la crítica).
- **Supresión Expresiva (SE): 24 puntos** (Media = 6.0, Nivel Muy Alto; ocultamiento deliberado de cualquier signo de temor).

Formulación Clínica: El paciente utiliza la supresión expresiva como conducta de seguridad nuclear. Al forzar una fachada inmutable, su activación autonómica se dispara (hiperhidrosis, taquicardia) y su memoria de trabajo queda colapsada, provocando bloqueos orales. No cuenta con repertorio de reevaluación para desarmar los pensamientos de juicio externo.

Plan Terapéutico y Resultados: Mediante TCC y experimentos conductuales de des-supresión (exposición a mostrar rubor voluntariamente en consulta y aulas) combinados con reestructuración cognitiva de creencias de autoexigencia, el paciente logró a los 3 meses: RC = **32 puntos** y SE = **13 puntos**, alcanzando soltura docente y normalización del ritmo cardíaco.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DE RIESGO

SUPRESIÓN SEVERA Y RIESGO DE SOMATIZACIÓN

Puntuaciones en SE ≥ 24 en pacientes con dolor crónico, cefaleas o colon irritable reflejan alexitimia funcional o represión afectiva extrema. Desaconsejar técnicas meramente tranquilizadoras; promover la validación somatosensorial y el procesamiento afectivo profundo.

DISTINCIÓN ENTRE REEVALUACIÓN Y RUMIACIÓN

Asegurarse de que las puntuaciones elevadas en RC correspondan a un cambio genuino de perspectiva que disminuya el afecto negativo y no a una hiperintelectualización defensiva o pseudoreevaluación rumiadora de naturaleza obsesiva.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(2), 348–362.
2. Cabello, R., Salguero, J. M., Fernández-Berrocal, P., & Gross, J. J. (2013). A Spanish adaptation of the Emotion Regulation Questionnaire. *European Journal of Psychological Assessment*, 29(4), 234–240.
3. Rodríguez-Carvajal, R., Moreno-Jiménez, B., & Garrosa, E. (2006). Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ). Versión española autorizada por los autores. *Universidad Autónoma de Madrid*.
4. Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 30(2), 217–237.